EPICRISIS MÉDICA

HOSPITAL : HOSPITAL DE SAN CARLOS N° EGRESO : 84694
SERVICIO : MEDICINA HSC
FECHA : 2024-05-17 08:48:00

DATOS DEL PACIENTE:

Nombre	: SERGIO CONTRERAS LANDEROS			RUN	: 4.343.104-8
F.Nac	: 09-01-1939	Edad	: 85 AÑOS, 4 MESES	Género	: Masculino
Dirección	: SAN CAMILO KM. 2,5			Comuna	: SAN CARLOS
Previsión	: PRAIS	Teléfono	: 0		
Fecha Ingreso	: 2024-05-11	Fecha Egreso	: 2024-05-17 08:48:00	Causal	: MEDICA
Condición	: VIVO	Destino	: HOSPITALIZACIÓN DOMICILIARIA	Derivación	:

DIAGNOSTICO(S) INGRESO

1. J90.X-DERRAME PLEURAL NO CLASIFICADO EN OTRA PARTE.

DIAGNOSTICO(S) EGRESO

1.Insuficiencia cardiaca aguda
--> Stevenson B compensada
-->Derrame pleural izquierdo
--> CF III
2. HTA
3. Hemoneumotorax en hospitalizacion previa
--> Fracturas costales izquierdas reciente

DIAGNÓSTICOS CIE10

1. I50-INSUFICIENCIA CARDIACA (DIAGNÓSTICO PRINCIPAL)
2. J90-DERRAME PLEURAL NO CLASIFICADO EN OTRA PARTE (DIAGNÓSTICO SECUNDARIO)
3. I10-HIPERTENSION ESENCIAL(PRIMARIA) (DIAGNÓSTICO SECUNDARIO)
4. S22.4-FRACTURAS MULTIPLES DE COSTILLAS (DIAGNÓSTICO SECUNDARIO)
5. I50-INSUFICIENCIA CARDIACA (DIAGNÓSTICO SECUNDARIO)

COMENTARIO DE EVOLUCIÓN / COMPLICACIONES

Paciente de 85 años con antecedentes de HTA, sin alergias conocidas. Antecedentes de hospitalizacion 06/04 hasta 30/07 tras haber sufrido caida en bicicleta con resultado de fracturas costales izquierdas y evoluciona con hemo-neumotórax que requiere instalación de SEP aspirativo. Paciente consulta derivado desde APS Teresa Baldechi con ic medica de obs TEP en SU del HSC se precisa disnea, tos de aparición súbita de 12 horas de evolucion. Ingresa para MNI, con aporte de o2 por naricera 3 litros, saturando limite, hipertenso, disneico, se inician puff de bromuro. Rx de torax evidencia derrame pleural izquierdo en contexto de fracturas costales previas secundarias a traumatismo, angiotac de torax sin hallazgos sugerentes de tromboembolismo pulmonar. Cardiomegalia, Ateromatosis cálcica, derrame pleural izquierdo. Paciente durante hospitalizacion evoluciona HDN estable, afebril, con mejoria progresiva de disnea, saturación variable requiriendo oxigeno suplementario de 1 a 2 lt por naricera para sat 92%. desde hace 24 horas sin requerimientos actuales de O2, paciente se mantiene hipersecretor con mala mecanica ventilatoria con requerimientos de kinesioterapia repetida, mantiene balance hidrico negativo, con evidencias de mejoria de congestion en contexto de manejo depletivo. deambulacion posible, con buena tolerancia a la via oral. dado evolucion favorable, con mejoria clinica y paraclinica y sin requerimientos de oxigeno suplementario, se decide seguir en HODOM para kinesioterapia respiratoria para manejo de movilizacion de secreciones dado antecedente de fractura costal que dificulta movilidad toracica.

PLAN DE MANEJO:

Hemodinamico/cardiovascular: paciente con diagnostico de ICA, con disnea severa y sintomatologia congestiva, se ingresa para manejo depletivo, de buena respuesta, se ajusta terapia en contexto de ICC,

actualmente recibiendo terapia depletiva VO, pendiente realizacion de ecocardiograma TT para cuantificar FEVI.
-Ventilatorio: Paciente con antecedentes de traumatismo de torax izquierdo, con fracturas costales multiples que dificultan su mecanica ventilatoria, en contexto de derrame pleural izquierdo secundario a IC, mantuvo con apoyo de O2 suplementario, kinesioterapia respiratoria 3 veces al dia verificando y titulando oxigeno, actualmente sin requerimientos. Alta y seguimiento por HODOM para manejo kinesico ante dificultad de movilizacion de secreciones.

INDICACIONES AL ALTA

1. -Continuar manejo kinesico en HODOM
2. -Reposo semisentado 30°
3. -Regimen hiposodico a tolerancia
4. -Mantener restriccion hidrica 800 cc al dia
5. -KNT motora y respiratoria
6. -losartan 50mg 1 c/dia vo
7. -Furosemida 40 mg 1 c/12 horas vo
8. -Espironolactona 25 mg c/12 hrs VO
9. -Empaglifozina 10mg c/dia VO
10. -Omeprazol 20 mg al dia VO
11. -Paracetamol 500 mg, 2 comp c/8hrs VO SOS
12. -Quetiapina 25 mg por noche vo
13. -Bromuro de ipratropio 4 puff c/4hrs por AC
14. -Brexotide 2 puff c/12 horas por AEC
15. -Pendiente Ecocardiograma TT ambulatorio
16. -Reconsultar SOS signos de alarma

EXÁMENES Y RESULTADOS

Crea: 1.0 | ELP: Na: 141/K:4,5/Cl: 108
PCR: 38 | NT-Probnp: 1639
Rx Torax: Derrame pleural izquierdo con fracturas costales izquierdas multiples
Angio TAC: sin hallazgos de TEP

DANIEL EDUARDO ACEVEDO PEREIRA
MEDICO TRATANTE
18431829-6

JEFE SERVICIO